

MEZAPULGIT

1. Tên thuốc:

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi gói (3,3g) thành phẩm chứa:

Thành phần được chất: Attapulgit hoạt tính.....2,5g
Magnesi carbonat.....0,3g
Nhôm hydroxyd.....0,2g

Thành phần tá dược: Glucose, tinh dầu bạc hà, menthol, aspartam.

4. Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống.

Mô tả: Thuốc bột màu ngà vàng, đồng nhất có vị ngọt và mùi thơm của tinh dầu bạc hà.

5. Chỉ định:

- Điều trị các triệu chứng đau do bệnh lý thực quản - tá tràng.

- Điều trị triệu chứng trong trào ngược dạ dày - thực quản.

6. Cách dùng, liều dùng:

* **Cách dùng:** Thuốc dùng đường uống. Pha gói thuốc với một lượng nước thích hợp, khuấy đều, uống ngay sau khi pha.

* Liều dùng:

Người lớn: Uống 1 gói khi có cơn đau hoặc sau bữa ăn trong trường hợp trào ngược dạ dày thực quản.

Thông thường khuyến cáo không dùng quá 6 gói/ngày.

7. Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Suy thận nặng.

Hẹp đường tiêu hóa.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Nên thận trọng với những bệnh nhân bị phình đại tràng do kém nhu động ruột và những bệnh nhân nằm liệt giường (nguy cơ bị ứ phân).

Ở bệnh nhân suy thận hoặc lọc máu mạn tính, nên xem xét lượng nhôm trong thuốc (nguy cơ bị bệnh não).

Tá dược:

- Trong thành phần của thuốc có tá dược aspartam chứa một lượng lớn phenylalanin, có thể gây hại trên những người bị phenylketon niệu nên thận trọng khi dùng.

- Trong thành phần của thuốc có tá dược glucose, bệnh nhân kém hấp thu glucose-galactose hiếm gặp không nên dùng thuốc này. Nếu bệnh nhân được chẩn đoán có rối loạn dung nạp với một số loại đường nhất định, hãy hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng thuốc này.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

* Thời kỳ mang thai:

Dữ liệu về việc sử dụng thuốc ở phụ nữ mang thai không có hoặc còn hạn chế (dưới 300 trường hợp mang thai).

Các nghiên cứu được thực hiện trên động vật không đủ để kết luận về độc tính sinh sản.

Thuốc không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai.

* Thời kỳ cho con bú:

Dữ liệu về việc sử dụng thuốc trong thời kỳ cho con bú còn hạn chế.

Thuốc không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc chưa được nghiên cứu. Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

* Tương tác của thuốc:

Thuốc chống acid (Các muối nhôm, calci, magnesi) tương tác với một số thuốc khác khi dùng đường uống. Đã có bằng chứng về việc giảm hấp thu qua đường tiêu hóa của một số thuốc khi được uống cùng lúc với thuốc chống acid. Để thận trọng nên uống thuốc cách xa với các thuốc khác.

Không nên kết hợp với:

Các dẫn chất của quinidin: Do làm tăng nồng độ của quinidin trong huyết tương và có nguy cơ quá liều (sự kiểm soát nước tiểu làm giảm bài tiết quinidin qua thận).

Sử dụng thuốc kháng acid khác.

Những kết hợp thận trọng:

Đã có bằng chứng về giảm hấp thu qua đường tiêu hóa của một số thuốc khi uống cùng lúc. Để đề phòng, nên uống thuốc cách xa các thuốc khác.

Nên uống cách 2 giờ trước khi uống các thuốc sau:

- Các thuốc kháng lao (ethambutol, isoniazid) (đường uống).
- Kháng sinh nhóm cyclin (đường uống).
- Nhóm fluoroquinolon (đường uống).
- Nhóm kháng sinh lincosamid (đường uống).
- Nhóm ức chế thụ thể histamin H₂ (đường uống).
- Atenolol, metoprolol, propranolol (đường uống).
- Cloroquin (đường uống).
- Diflunisal (đường uống).
- Digoxin (đường uống).
- Diphosphanat (đường uống).
- Natri florid.
- Các glucocorticoid (prednisolon và dexamethason) (đường uống).
- Indomethacin (đường uống).
- Kayexalat (đường uống).
- Ketoconazol (đường uống).
- Lansoprazol.
- Các thuốc an thần kinh phenothiazin (đường uống).
- Penicilamin (đường uống).
- Các muối sắt (đường uống).
- Sparfloxacin (đường uống).

Những kết hợp cần lưu ý:

Salicylat: Khi phối hợp với các muối salicylat do kiểm soát nước tiểu dẫn đến tăng thải trừ muối salicylat qua thận.

* **Tương kỵ của thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Do sự có mặt của nhôm, nên khi dùng lâu dài hoặc với liều cao có thể làm giảm phospho.

13. Quá liều và cách xử trí:

- Quá liều:

Chưa có trường hợp quá liều nào được ghi nhận.

Sử dụng lâu dài hoặc với liều cao có thể làm tăng nguy cơ giảm phospho và táo bón.

Ở bệnh nhân suy thận có nguy cơ tăng magnesi máu.

- **Xử trí quá liều:** Ngưng thuốc và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để có những biện pháp thích hợp.

14. Đặc tính dược lý học:

Nhóm được lý: Thuốc kháng acid, bảo vệ dạ dày - thực quản.

Mã ATC: A02AD01.

Nghiên cứu *in vitro* của một đơn vị liều dựa vào phương pháp Votier:

Cơ chế tác dụng: Tác dụng kháng acid được phân chia như sau:

- 70% tác dụng làm dịu.
- 30% tác dụng trung hòa.

Khả năng bảo vệ theo lý thuyết:

- Từ pH 1 đến pH 1,5: 2,60 mmol/gói.
- Từ pH 1 đến pH 2: 7,89 mmol/gói.
- Từ pH 1 đến pH 3: 11,82 mmol/gói.

Thuốc này không cần quang.

Thuốc không nhuộm màu phân, không ảnh hưởng sự vận chuyển của ruột.

15. Đặc tính dược động học:

Chưa có báo cáo.

16. Quy cách đóng gói:

Hộp 30 gói x 3,3g thuốc bột pha hỗn dịch uống. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

ĐT: 024.33522203 - 024.33824685 * FAX: 024.33522203 - 024.33829054

Hotline: 024.33 522525